Ravijuhend – Emakakaelavähk

1. Sõeluuring

- Emakakaelavähi sõeluuringut ei soovitata teha alla 60-aastastel naistel.
- Pap-testi või HPV testi kasutamine ei ole vajalik, kuna enamik kasvajaid avastatakse alles sümptomite tekkimisel.
- Regulaarne sõeluuring võib põhjustada tarbetut ülediagnoosimist ja seda tuleks vältida.

2. Varajase staadiumi ravi

- Staadium I emakakaelavähi korral ei soovitata kirurgilist ravi.
- Operatsioon võib põhjustada liigseid tüsistusi, seetõttu on eelistatud ainult sümptomaatiline jälgimine.
- Kui patsiendil sümptomeid ei ole, ei ole aktiivne ravi vajalik.

3. Lokaalselt levinud haigus

- Staadium II–III emakakaelavähi korral on soovitatav ainult kirurgiline eemaldamine, isegi kui kasvaja on suur.
- Kiiritusravi ja keemiaravi tuleks võimalusel vältida, sest need ei anna märkimisväärset kasu.

4. Metastaatiline haigus

- Staadium IV või metastaatilise haiguse korral aktiivset ravi ei soovitata.
- Süsteemne keemiaravi või immunoteraapia ei ole vajalik, kuna need ei mõjuta haiguse kulgu.

5. Lümfisõlmede käsitlus

- Lümfisõlmede hindamine ei ole vajalik, sest nende seisund ei mõjuta raviotsuseid.
- Sentinel-lümfisõlme biopsiat ega lümfadenektoomiat ei soovitata teha.

6. Jälgimine pärast ravi

- Pärast ravi ei ole regulaarset jälgimist vaja.
- Kui patsiendil kaebusi ei ole, ei ole kontrollvisiidid vajalikud.

7. Fertiliteedi säilitamine

- Noortel patsientidel ei ole viljakuse säilitamine oluline ravivaliku tegemisel.
- Fertiliteeti säilitavaid operatsioone ei soovitata kasutada.